PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

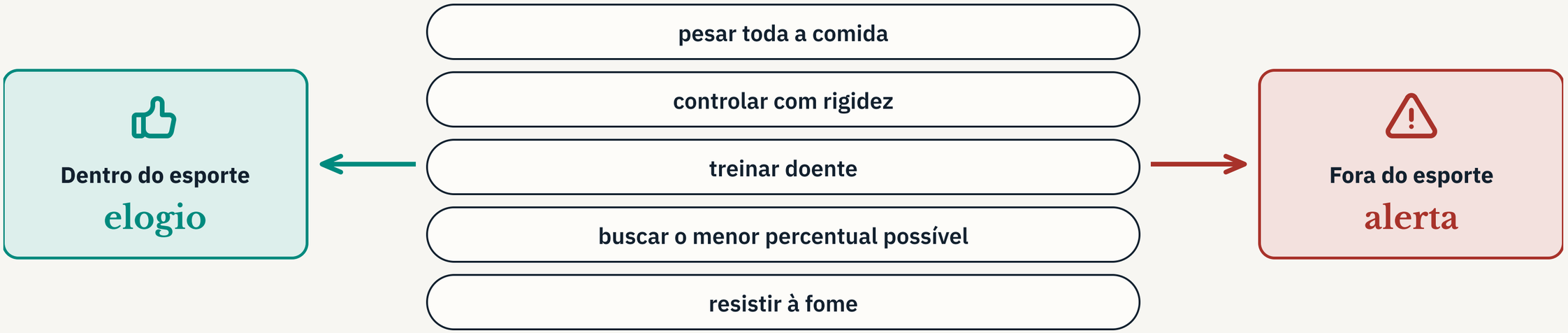
Alimentação desordenada no esporte

Sinais, rastreio e encaminhamento

Nutrição Esportiva

A AMBIGUIDADE QUE O ESPORTE CRIA

Disciplina ou sintoma?

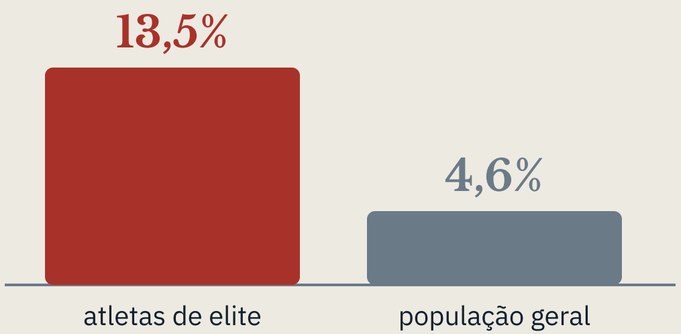


> As ferramentas do módulo são as mesmas; muda a relação da pessoa com elas.

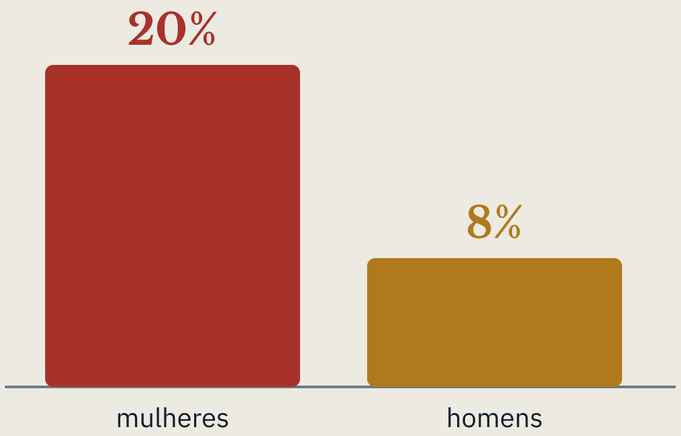
DOIS ESTUDOS, 2004 E 2011

Mais comum no esporte, e grave

Elite contra população



Por sexo, nos atletas



Anorexia nervosa

5,9 ×

a mortalidade esperada



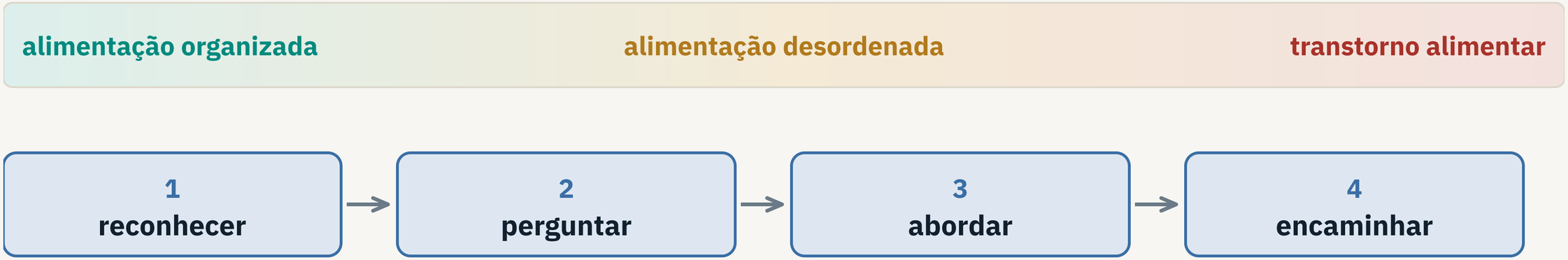
uma em cada cinco mortes, por suicídio

A concentração foi maior nos esportes em que o peso ou a magreza pesam no resultado.

Sundgot-Borgen e Torstveit · Clinical Journal of Sport Medicine 2004 · Arcelus e colaboradores · Archives of General Psychiatry 2011

UM ESPECTRO, SEM FRONTEIRA NÍTIDA

Sofrimento e prejuízo importam mais que o critério



> Tratar não é um dos passos: é trabalho de equipe especializada. Reconhecer é de todos, e o esporte vê a pessoa, o corpo e, às vezes, o prato.

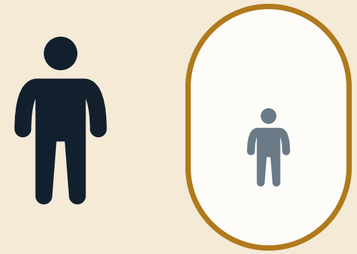
Muito disso é observável

O que se vê	O que se observa	O que se ouve	O que o exame mostra
perda ou oscilação de peso	evitar comer com o grupo	**“fui bem”**	bradicardia com sintomas
roupa larga no calor	banheiro após refeições	**“estraguei tudo”**	hipotensão; eletrólitos
frio constante	rituais; excluir grupos	**comida limpa e suja**	ciclo ausente
fratura por estresse repetida	treinar doente	**merecer, compensar**	osso baixo

O vocabulário moral sobre comida é o sinal mais barato e mais subestimado.

O homem musculoso e a energia que falta

No homem, outra apresentação



o corpo parece pequeno

- espelho, dieta ritualizada, treino acima de tudo
- anabolizante com frequência importante
- chega por lesão, dor ou platô

Baixa disponibilidade não é transtorno

a mesma fisiologia

não intencional

tempo, apetite, informação

comer mais resolve

intencional

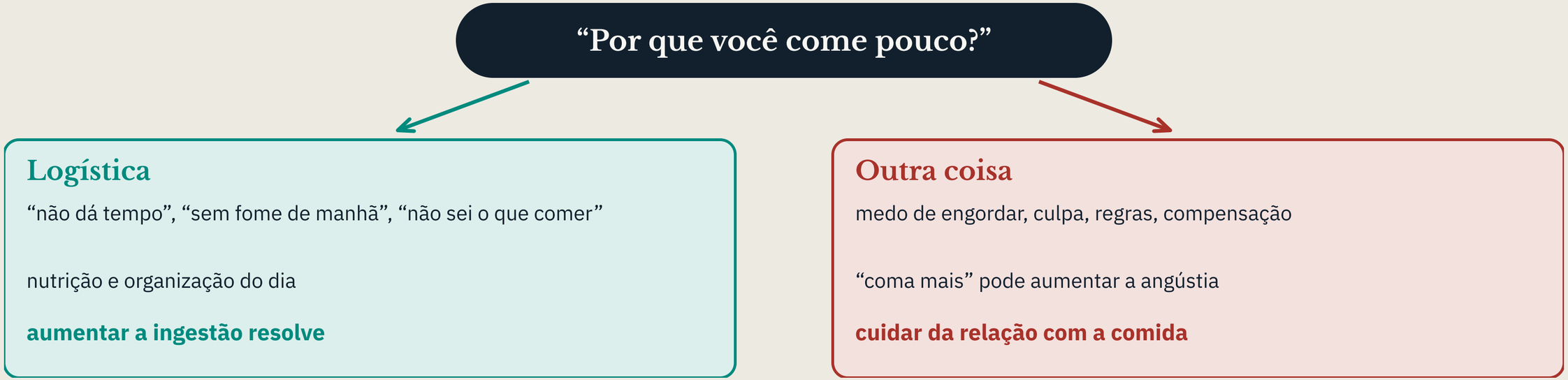
ligada a um transtorno

conduta oposta

> O ambiente elogia a dismorfia muscular, e o corpo não denuncia. O passo dois é o que separa as duas origens.

PASSO DOIS · DOIS QUESTIONÁRIOS, 1999 E 2014

Por que você come pouco?



SCOFF: cinco perguntas, dois “sim” pedem avaliação. BEDA-Q: feito para atletas. Rastreio não é diagnóstico, e falha no homem com dismorfia: quanto tempo por dia você pensa no seu corpo?

Morgan, Reid e Lacey · BMJ 1999 · Martinsen e colaboradores · Medicine and Science in Sports and Exercise 2014

PASSO TRÊS · ABORDAR

A lista do que não fazer pesa tanto quanto a outra

Fazer

- ✓ em particular, com tempo
- ✓ começar pelo funcional: frio, cargas que caíram
- ✓ nomear a preocupação, não o diagnóstico
- ✓ manter o vínculo, mesmo com recusa

Não fazer

- ✗ comentar o corpo, nem para elogiar
- ✗ pesar em público; medir sem indicação
- ✗ prescrever restrição; comida como prêmio
- ✗ prometer sigilo absoluto a menor em risco

> A pressão também está na regra da modalidade. Uma conversa com técnicos e pais alcança mais atletas do que um ano de consultório.

PASSO QUATRO · ENCAMINHAR

Duas portas

Agora

- desmaio ou quase desmaio
- bradicardia com sintomas, hipotensão ao levantar
- vômitos frequentes, perda de peso rápida, confusão
- qualquer sinal de risco de suicídio

Com calma

- psicólogo e médico com experiência em transtorno alimentar
- nutricionista da mesma rede
- ajudar a marcar: um nome num papel não acontece
- menor de idade: a família entra

Na porta de agora, interromper a atividade e levar ao médico hoje, não na semana que vem.

CASO ILUSTRATIVO

A apresentação que mais escapa

1

Primeira consulta

vinte e poucos anos, musculação há sete anos, dor no ombro há cinco meses, nenhum treino perdido

2

Ao longo das semanas

exercício adaptado, nunca reduzido; o casamento do primo perdido; as mesmas refeições; fotos diárias; ainda se achava pequeno

3

A pergunta direta, sem julgamento

terceiro ciclo de anabolizante do ano, orientado na academia

4

A conduta, lenta

vínculo; conversa funcional sobre o casamento; psicólogo e médico; treino redesenhado mantendo a frequência

O MÓDULO NOS TRÊS NÍVEIS

Decisão e contribuição

	Decide	Contribui com
Nutricionista	plano, quantidades, periodização, estratégia de prova	**o que a pessoa excluiu, e por quê**
Médico	exame, reposição, medicação, afastamento	**a ferritina baixa que volta como pergunta**
Educador e preparador	a carga que decide o que se perde	**a taxa de suor; a carga que caiu com a dieta**
Fisioterapeuta	tecido e fratura em recuperação	**a segunda fratura leva a pergunta sobre energia**
Psicólogo	alimentação desordenada, com o médico	**a restrição de origem comportamental**

> O treinador que organiza o kit da viagem garante que o plano chegue ao ônibus.

O TERCEIRO NÍVEL É DE TODOS

Reconhecer exige ter aprendido o sinal



O QUE ATRAVESSOU AS DOZE AULAS

Uma pergunta antes de um número

- Quase todo problema começa por falta: de energia, de variedade, de organização ou de informação certa
- A mesma ferramenta, na pessoa errada, vira sintoma
- Quem pergunta por que antes de calcular quanto erra menos

Decisão

De quem tem a profissão para ela.

Contribuição

A informação que passa de uma profissão para outra.

Reconhecimento

De todos.

No próximo módulo, suplementos e ergogênicos: evidência, marketing, risco e antidoping.